

09 - Alimentation et Hydratation en soins palliatifs - Pr. ZIADI

Aujourd'hui, ce sera l'alimentation et l'hydratation en soins palliatifs. Je pense que vous avez déjà fait les cours avec le professeur Hashimi ? Vous avez fini les cours ? Très très bien. Donc en fait, c'est une continuité à ce que vous avez vu avec le professeur Hashimi.

Je ne sais pas, ces cours, c'était sur quoi au juste ? Oui, mais les soins palliatifs, la communication en fin de vie avec la famille, c'est ça ? Les approches palliatives, très très bien. Alors, quand on parle de soins palliatifs, si on veut poser des questions comme ça avant de démarrer le cours, qu'est-ce qui vous passe par l'esprit en parlant de soins palliatifs ? Pour vous, c'est quoi ? Comment ? C'est quel type de patient ? Est-ce que vous en avez déjà vu des patients en soins palliatifs ? C'était quoi au juste ? Est-ce que quelqu'un peut me parler de ça ? En fait, d'une expérience peut-être que vous avez déjà passé par des services où ils prennent en charge des patients en fin de vie ou que vous avez vu peut-être des patients en fin de vie. C'est quoi pour vous un patient en fin de vie en soins palliatifs ? Les patients cancéreux, oui.

Les patients cancéreux, quoi encore comme profil de patient ? La gériatrie, les sujets âgés qui sont, si vous voulez, des sujets qui sont plutôt vieux. Nous, en anesthésie, on parlait avant, par exemple, d'anesthésie de sujets âgés. Après, on a commencé à parler ces dernières années de l'anesthésie chez le vieillard, carrément.

Donc, c'est vraiment un sujet âgé, mais c'est au-delà du sujet âgé, en fait. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui ont, par exemple, 90 ans, qu'on va anesthésier pour un geste chirurgical. Parfois, ils sont tellement vieux que finalement, ils ne sont pas malades.

Ils sont vieux. C'est une évolution, si vous voulez, physiologique. Et peut-être que celui ou celle qui aura cette chance d'être vieux ou vieille, c'est une chance aussi de vieillir.

Et surtout si on vieillit bien. Ça, c'est bien, parce que vieillir avec des handicaps et tout ça, on devient un peu lourd par rapport à notre entourage, à nos familles et tout ça. Très, très bien.

Donc, comme vous l'avez dit, soins palliatifs, c'est surtout des patients. Essentiellement, ce sont des patients en fin de vie. C'est des patients qu'on voit dans les services de gériatrie, qu'on voit dans les services d'oncologie.

D'accord ? Donc, ce sont des patients, généralement, qui sont arrivés à un niveau, si vous voulez, d'évolution de la maladie. Et ça, c'est essentiellement chez les patients d'oncologie. Et avec un pronostic qui est connu.

Et on est là pour les accompagner, en fait. C'est un accompagnement, si vous voulez, de ces patients à un stade évolutif, si vous voulez, d'une maladie qui est connue. Bien évidemment, il n'y a pas que les patients en oncologie.

Il y a aussi les patients qui ont des maladies neurologiques, par exemple, à des stades très, très avancés et dont le pronostic est connu. Un pronostic qui, généralement, n'est pas bon. D'accord ? Et on sait, généralement, que le patient va passer, au bout de quelques semaines et au bout de quelques mois, en fait.

Et donc, on a approximativement, on ne peut pas savoir, il m'a oublié d'y aller, bien évidemment. Mais ça, c'est des prévisions, si vous voulez, scientifiques ou prévisions médicales par rapport à l'évolution de ces patients. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble ces patients-là.

Qui sont ces patients, déjà ? Et comment, si vous voulez, les accompagner en soins palliatifs ou en fin de vie ? Alors, quand on parle de soins palliatifs, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que les soins palliatifs ? Ce sont des soins actifs qui sont délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Alors là, dans cette définition, on a le mot soins actifs, c'est-à-dire qu'on va administrer aux patients des médicaments, qu'on va, si vous voulez, instaurer une procédure ou des procédures de prise en charge, soit par exemple pour alimenter ou pour hydrater, etc. Donc, on va faire quelque chose activement.

Et puis, délivré dans une approche globale, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'on alimente un patient, ce n'est pas intéressant plutôt d'alimenter un patient en soins palliatifs, alors que de l'autre côté, le médecin traitant qui prend en charge le patient, par exemple pour son cancer ou je ne sais pas quoi, il a déjà arrêté de lui délivrer les traitements, par exemple, dédiés à la phase évolutive dans laquelle se trouve le patient. Cela ne sert à rien, il faut que l'approche soit globale, il faut que l'approche soit multidisciplinaire et qu'on soit tous sur la même voie. C'est-à-dire que moi, en tant que, par exemple, oncologue, si moi j'estime que l'évolution du patient ou l'état du patient nécessite un arrêt carrément du traitement éventuellement que je vais donner ou que je donne au patient, normalement mon confrère qui prend en charge le patient aussi avec moi ne doit pas aller faire autre chose parce que sinon on sera sur deux voies qui sont complètement différentes.

Il faut vraiment que ce soit une approche globale. J'alimente mon patient, je l'hydrate, mais il faut aussi qu'il soit pris en charge, qu'il ne soit pas lâché par un autre médecin, un autre confrère, par exemple, comme le médecin traitant, etc. Là, cette notion est très importante, l'approche globale.

Rappelez-vous de cette notion d'approche globale. D'une personne qui est atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale ? Évolutive, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est connue grave, le pronostic est connu fatal, mais le patient en a pour quelques mois, ce n'est pas un patient qui est agonisant. Parce que si le patient est agonisant, à quoi ça sert notre approche ? Elle ne sert absolument à rien.

À ce moment-là, il faut s'abstenir et laisser le patient tranquille. Et donc, il faut faire attention à ces notions et on va voir sur d'autres diapositives les définitions exactes en fonction de l'état

évolutif ou les phases d'évolution de la maladie. L'objectif de nos approches en soins palliatifs, c'est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle.

Comme vous le savez, un patient qui a un cancer d'un mauvais pronostic, généralement, c'est un patient qui a été informé de sa maladie, de son évolution et de son pronostic. La plupart, d'ailleurs, des patients sont au courant, ils savent qu'ils ont une maladie évolutive, arrivée à un stade dépassé, on va dire dépassé sur le plan thérapeutique. Et donc, ces gens-là, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des gens qui vont avoir une certaine souffrance psychique, parce qu'en fait, l'être humain a peur de mourir de toute manière.

Même si on est vieux, on a peur de mourir. C'est toujours la peur d'aller à un endroit dont on n'a aucune idée sur ce qui va se passer, etc. Donc, il y a une certaine peur.

Et donc, il y a une certaine souffrance psychique pour les gens qui ont déjà une maladie et qui attendent justement l'arrivée, finalement, de ce jour-là, de ce jour X. Et donc, notre approche et l'objectif de notre approche, c'est quoi ? C'est de soulager la douleur physique, bien sûr, parce que peut-être que le patient a mal, etc. Il y a des symptômes qu'on doit corriger, bien évidemment, mais prendre en considération que ce patient, il a une souffrance psychologique. Et d'où vient la multidisciplinarité, justement, de cette prise en charge ? Donc, certainement, il y aura des psychiatres qui vont aussi intervenir dans, si vous voulez, la prise en charge de ces patients en fin de vie.

Bien sûr, interdisciplinaire, on vient de le citer. Donc, interdisciplinaire, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir dans cette prise en charge, mais le patient, il est au centre, bien évidemment, de cette prise en charge. Mais il n'y a pas que le patient.

Il y a le patient, il y a sa famille, ses proches, son entourage, sa situation sociale, etc. C'est très important parce qu'en fin de vie, les patients ne sont pas forcément hospitalisés au niveau de l'hôpital ou au niveau d'un service. Donc, qui va les prendre en charge ? Bon, nous, en tant que médecin, on va prescrire, on va leur dire, voilà, il faut faire passer ceci, cela, etc.

Mais après, qui va faire cela ? Qui va veiller sur cela ? Généralement, c'est l'entourage. S'il n'est pas hospitalisé, bien évidemment, et la plupart des gens qui sont en fin de vie, je le redis encore une fois, ils ne sont pas à l'hôpital, ils sont plutôt à domicile. Donc, il faut prendre en considération, quand on veut parler avec une personne et quand on veut instaurer une approche chez ces patients-là, prendre en considération l'entourage du patient, la famille, les proches, etc.

Cela ne sert à rien si c'est une personne, par exemple, qui vit seule. Qui va la prendre en charge ? Qui va veiller sur son alimentation ? Qui va veiller sur ces petits détails que nous, on va instaurer ? Personne. Et donc, cela ne sert absolument à rien.

Donc, finalement, il faut faire une analyse, voir un peu le patient, où est-ce qu'il vit, avec qui il vit,

son niveau social, c'est important. Parce que dire, voilà, on va prescrire, par exemple, dans l'alimentation des vitamines, des complexes vitaminés, de je ne sais pas quoi. Le patient, il est démuné, il ne pourra pas acheter tout cela.

Sa famille est démunie. Est-ce que vous allez prescrire ? Cela ne sert à rien. Ils ne vont pas lui administrer, ils ne vont pas l'acheter.

Donc, dès le début, il faut qu'on fasse une sorte d'anamnèse qui est un peu spécifique, où on cherche des notions ou des informations sur le patient, sur ses habitudes, etc., mais aussi sur son entourage. Est-ce que vous avez compris un peu l'idée ? En soins palliatifs, le malade est considéré comme un être vivant. Parce que si on le considère comme étant agonisant, ce n'est pas la peine qu'on intervienne.

C'est bon, le patient est agonisant, on ne fait rien généralement chez ces patients-là. Et on considère que la mort est un processus naturel. Est-ce que vous avez compris cette phrase ? C'est-à-dire qu'en soins palliatifs, on considère que le malade est éternel et qu'il va survivre.

D'accord ? Cela, c'est notre considération. Mais en même temps, on considère que la mort est une évolution naturelle chez ce patient. Donc un patient cancéreux, il a un cancer avec des métastases, on sait qu'il va vivre.

Scientifiquement parlant, médicalement parlant, on peut estimer sa survie, par exemple, je dis du n'importe quoi, à un an, par exemple. Et donc là, pour intervenir, pour soi-disant entamer cette procédure de prise en charge, il faut considérer que le patient va survivre quelques mois quand même. Et en même temps, on doit considérer la mort comme une évolution qui est naturelle.

On n'est pas là pour aller corriger, si vous voulez, ou empêcher la survenue de la mort. On n'est pas dans le traitement curatif. Ce n'est pas ce qu'on cherche.

Mais on accompagne le patient pour une bonne qualité de vie, si vous voulez, ces semaines, ces jours, ces mois qui lui restent. D'accord ? Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ici qu'en soins palliatifs, le patient est considéré comme un être vivant. D'ailleurs, c'est normal.

Et que la mort est un processus naturel. Et ceci ou ce raisonnement-là va nous permettre d'éviter des investigations et des traitements qui sont déraisonnables chez le patient. C'est-à-dire un patient qui est en fin de vie.

Je vous donne un exemple. Un patient qui a un cancer métastatique à un stade terminal. Il n'y a pas d'indication chirurgicale.

Il a des métastases. Les oncologues ont démarré un protocole, mais en palliatif, de chimiothérapie. Mais ce n'est pas pour guérir la maladie.

D'ailleurs, ils ne vont pas opérer. Donc on ne va pas guérir la maladie. Mais on veut juste, si vous

voulez, diminuer un peu la taille de la tumeur pour avoir moins de symptômes, pour améliorer la qualité de vie, etc., tout ce que le patient peut supporter, si vous voulez, ces produits, etc., et ces protocoles.

Donc, chez ce patient-là, est-ce que vous allez vraiment demander des investigations, genre, allez, tiens, ce patient, je vais lui faire des scanners, je vais peut-être l'alimenter avec une technique X ou Y, je vais être agressif, je vais demander, je ne sais pas, je vais poser des cathéters de je ne sais pas quoi. Là, cette agressivité ne va pas avec l'idée qu'on a. Nous, on veut accompagner le malade. Traiter peut-être les symptômes gênants, etc., mais juste à titre symptomatique.

On n'est pas dans le curatif. Donc ce n'est pas possible de poser des investigations qui sont à la limite, on peut dire, qui sont déraisonnables, puisqu'on n'est pas dans le curatif. Est-ce que vous avez compris ? Tant qu'on est dans le palliatif, il ne faut pas aller faire des investigations, etc., comme si c'était du curatif, comme si on veut absolument changer le pronostic du patient et traiter la maladie causale, etc.

On n'est pas dans cette démarche. On ne va pas la traiter. On est sûr qu'on ne va pas la traiter.

D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on est en soins palliatifs. On ne va pas la traiter, mais on va améliorer la qualité de vie de ce patient en fonction, chaque patient, en fonction de son état, de sa maladie, de son état évolutif, etc. Est-ce que vous avez compris cette idée ? Voilà.

Il y a plusieurs options. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des gens en soins palliatifs sont chez eux, à domicile, mais parfois on les prend dans des petites hospitalisations ou des consultations. Par exemple, un patient qui est hospitalisé chez lui, métastase pulmonaire d'un cancer, je dis du n'importe quoi, un cancer de prostate.

C'est un patient qui s'encombre fréquemment, qui nécessite des aspirations, etc. Si la famille n'a pas un système aspiratif à domicile, ce sont des patients qui viennent souvent au niveau de l'hôpital juste pour leur faire des aspirations, etc., et les rendre chez eux. On fait juste des petits gestes et le patient rentre chez lui.

Ce sont des patients souvent qui sont à domicile. Parfois, on a des patients qui sont en fin de vie et qui sont au niveau de l'hôpital. Là, c'est surtout dans les services de gériatrie.

C'est rare chez nous, dans notre contexte, parce que la plupart ailleurs, il y a des services, il y a des hôpitaux qui prennent en charge ou qui, si vous voulez, hospitalisent les sujets âgés dans le cadre, si vous voulez, d'une prise en charge, je dirais, palliatif de fin de vie ou d'accompagnement ou comment on appelle ça. Mais ici, dans notre contexte marocain, des centres de gériatrie dédiés à la gériatrie, il n'y en a pas. Il y a des services, je pense, mais il n'y a pas vraiment de structures qui sont vraiment dédiées à ce genre de patients.

Il y a aussi des services d'oncologie qui prennent parfois des patients qui sont en fin de vie. Mais généralement, comme vous le savez très bien, dans nos services et surtout au niveau du CHU, la plupart des patients, on a beaucoup de patients qu'on prend en charge et donc pour trouver des places et pour dédier des places, spécialement pour ces gens-là qui sont en fin de vie, c'est vraiment très, très rare et généralement, ils ne font pas ça. Ils ne prennent pas ces patients et ils demandent à leur famille de les garder à domicile, de les ramener, bien sûr, en cas de besoin, s'il y a des petits gestes comme ça à faire.

Alors, l'alimentation et l'hydratation, ce sont deux volets primordiaux dans l'approche parce qu'alimenter, c'est nourrir et hydrater, ça vient de l'hydratation, ça vient de l'eau. Donc, finalement, ce sont deux éléments essentiels à la survie de l'être humain, si on veut dire. Et donc, pour accompagner un patient, même en fin de vie, c'est l'alimentation et l'hydratation, ce sont deux volets principaux dans cette procédure, finalement, qu'on va entamer.

Il faut savoir qu'ils répondent en soins palliatifs. L'alimentation et l'hydratation répondent à des protocoles qui sont bien adaptés, qui sont bien définis. On n'alimente pas juste comme ça, chacun fait ce qu'il veut, etc.

Il y a des règles que tous les gens ou tous les professionnels qui prennent en charge ce genre de patients doivent suivre. Et donc, on n'a pas trop le choix que chacun fait ce qu'il veut. Il y a des règles à suivre.

Ça nécessite une grande vigilance pour ne pas aggraver l'état préexistant des patients aux soins palliatifs. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Pourquoi il faut être vigilant et comment on peut aggraver l'état préexistant des patients? Quelqu'un a une idée? Oui, possible. On peut mettre un sujet âgé, par exemple, en surcharge hydrique.

Donc, on peut l'aggraver. C'est un patient qui peut, suite à un remplissage vasculaire massif inadapté, faire une surcharge pulmonaire, un OAP, un œdème pulmonaire, et présenter une détresse respiratoire. Donc, on va l'aggraver davantage, bien évidemment.

Et on sera amené à corriger ce qu'on a fait par des médicaments, par des gestes, par des trucs, parfois même qui disent surcharge. Il n'y a pas que l'asilix. Il y a aussi la dialyse, parfois, lorsqu'on est obligé.

Et ça, c'est vraiment déraisonnable, déraisonnable comme attitude. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et être vigilant. L'alimentation et l'hydratation, elles nécessitent aussi une évaluation préalable et une intégration des membres de la famille dans la décision.

Et bien sûr, l'accord du concerné. Comment? Alors, pour alimenter un patient, il faut savoir s'il a besoin de quoi au juste. Pour l'alimenter, il faut évaluer.

Donc, il faut qu'on voit un peu. Est-ce qu'il est dénutri? Comment il est sur le plan nutritionnel?

Pour savoir ce qu'on va lui donner, bien évidemment. Il faut toujours évaluer avant de démarrer quoi que ce soit.

L'intégration des membres de famille, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il faut qu'il soit là et qu'il soit intégré, si vous voulez, dans toutes les questions, toutes les décisions prises, bien sûr, sur le malade. Et il y a un point essentiel.

Et d'ailleurs, rappelez-vous de cette notion, s'il vous plaît. C'est que le patient, lorsqu'il est capable de parler, donner son avis, bien sûr, parce que parfois, en soins palliatifs, vous allez vous retrouver devant des patients qui sont incapables, qui sont dans des états neurologiques, par exemple, qui ne permettent pas, en fait, aux patients de vous dire ce qu'ils pensent. Et le patient, il a le droit de dire qu'il a envie que vous lui fassiez cette procédure ou non.

S'il refuse, vous ne devez pas le faire. D'accord? Donc, l'accord du patient, l'accord du concerné, parce qu'en gériatrie, on ne va pas dire un patient, c'est un sujet âgé. Et donc, il est primordial, son accord.

S'il vous dit non, il ne faut pas imposer. Il ne faut pas imposer. D'accord? La famille, elle est intégrée et il faut l'intégrer, justement, dans la prise en charge, en fait, dans la décision, parce que c'est son entourage, finalement, et c'est eux qui seront avec le patient dans les petits détails.

Donc, c'est important qu'il soit là, qu'il discute avec vous, qu'il donne leur avis aussi. Mais l'avis du patient, il est important. L'avis du patient est important.

Alors, regardez, j'ai mis cette caricature. En fait, vous voyez le patient, il a des perfusions partout, il descend, il est perfusé, il est réchauffé, il est scopé. Il en a ras-le-bol, le patient.

Alors, les docteurs, ils sont là. Le patient qui crie, il veut mourir, parce qu'il est fatigué de tout ce qu'on lui fait. Et les médecins, ils s'acharnent.

Ils s'acharnent, voilà. Donc, pour eux, ils ont perfusé, ils ont opéré, ils ont greffé, ils ont mis des prothèses. Ils ont donné des traitements à droite et à gauche.

Donc, il faut absolument que le patient reste et qu'il résiste à ce qu'ils font. D'accord? Ça, c'est une, si vous voulez, c'est une approche caricaturale de ce qui se passe chez ces patients qui sont tellement fatigués qu'ils n'ont plus envie de voir un médecin passer à côté d'eux. Alors, quels sont les principes de la prise en charge en soins palliatifs? Alors, il y a des points qui concernent le patient en lui-même ou la personne concernée.

Il faut préserver sa dignité. C'est très important. Respecter son libre choix.

C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut l'impliquer dans la prise en charge, dans la prise de décision, bien évidemment, en se basant sur les croyances du patient et sur ses volontés. Vous savez qu'ailleurs, le patient, il a le droit de vous dire ne me réanimez pas, laissez-moi

tranquille. Bien sûr, s'il est hospitalisé, s'il est encore jeune, etc., le médecin doit faire son travail de toutes les manières.

On ne va pas laisser crever un patient parce qu'il nous a dit cette phrase. Mais lorsqu'ils sont en soins palliatifs, lorsqu'ils sont en phase terminale d'évolution de maladie, etc., ailleurs, ils sont obligés d'accepter ce que dit le patient, en fait. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se réunissent, le médecin traitant, les autres médecins qui interviennent, etc., l'infirmière, parce qu'elle a un rôle primordial, l'infirmière qui est avec le patient.

Finalement, on peut dire que c'est elle qui décide, en fait. Elle donne son avis, mais son avis, il compte réellement parce que c'est elle qui connaît le patient, qui le voit 24 heures sur 24. Elle est à côté, elle connaît sa famille, elle connaît les détails plus que nous, les médecins.

Et donc, ils font comme une réunion. C'est une petite réunion, une mise au point, etc., éthique. Et dans cette réunion, avec des fiches qu'ils doivent remplir, ils discutent.

Et l'infirmière, elle parle du patient, elle dit que le patient, il m'a dit qu'il ne veut plus de soins, qu'il faut arrêter, etc., et qu'il ne veut plus qu'on lui fasse quoi que ce soit, qu'on doit lui enlever la perfusion et tout ça, qu'on le laisse tranquille. Et vous savez qu'après ces discussions, généralement, la décision est prise et quand elle est prise, s'il décide, si le staff décide d'arrêter, ils vont arrêter, ils ne vont pas poursuivre les soins palliatifs. On parle toujours des soins palliatifs, on est bien d'accord.

On n'est pas dans les patients, on n'est pas chez les autres types de patients. Donc, est-ce que vous avez compris un peu l'idée ? Ça vous apparaît peut-être un peu bizarre, comment ça se fait ? On va le laisser crever, on va le laisser mourir. Mais finalement, c'est ce qu'on fait, même nous, au niveau des services, au niveau des différents services, au niveau des urgences.

Quand on vous ramène, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, un patient, par exemple, qui vient avec un AVC ischémique étendu, par exemple, AVC bilatéral des deux champs, des deux hémisphères, et que le patient s'approche plus à la mort encéphalique, par exemple, et que la famille le ramène, bien sûr, le patient est inconscient et c'est bon, il est devant vos pronostics, etc. Et que la famille vous demande, est-ce que vous allez lui faire quelque chose ? Alors nous, en tant que réanimateur, on lui dit, voilà, on va le mettre juste sous oxygène, alors après, c'est un sujet âgé, il faut qu'on discute avec vous l'intubation, parce que de toutes les manières, on ne va rien récupérer, il est presque en arrêt cérébral, en mort cérébrale, et donc du coup, il faut qu'on discute avec vous. Pour l'intubation, ça nous apparaît un peu agressif pour lui, un sujet âgé à ce stade, etc.

Alors la famille, quand on lui explique ça, elle nous dit, vous savez, ne faites rien du tout, on le ramène avec nous. Et il le ramène finalement. Et nous, on respecte ce choix, en fait, le choix de la famille.

Est-ce que vous avez compris ? Parce que là, on n'est pas devant des malades qu'on va sauver, on est sur une autre voie. C'est un patient qui a une maladie connue, une phase évolutive connue, de mauvais pronostics, et il sent vraiment dans une phase qui est, si vous voulez, grave, de l'évolution de la maladie. Donc on n'est pas dans le patient où il y a une réversibilité, où il y a une possibilité de régler le problème de la pathologie sous-jacente, ou de guérir le patient, etc.

On n'est pas dans cette option. On est dans l'option, il n'y a pas de guérison, médicalement parlant, il n'y a pas de guérison. C'est là où on parle, on commence à parler des soins palliatifs.

Donc voilà. Bien sûr, quand on veut prendre en charge un patient, il faut préserver bien sûr sa dignité, il faut le respecter, respecter le fait que c'est un être humain, et puis même s'il est en fin de vie, il faut se comporter avec lui sur le plan émotionnel et sur le plan communication, etc., d'une manière qui est respectueuse. Ce n'est pas parce qu'il est en fin de vie qu'on va commencer à dire « Ah non, mais c'est bon, le patient, il passe de toutes les manières.

» Non, non. Il faut le considérer, préserver sa dignité. Et là, ça doit faire partie de votre approche avec tous les patients, tous les malades.

Il faut toujours avoir cet empathie avec eux. Bien sûr, prendre en charge la souffrance globale, c'est dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième point, puisqu'on a parlé du patient, la personne concernée, il y a aussi la famille.

Il faut avoir ce don de savoir communiquer avec une famille, de les informer, de leur donner des informations continues sur l'évolution de l'état de santé du patient tout au long du processus de la prise en charge. Et là, ce n'est pas qu'en soins palliatifs. Quand vous êtes dans un service, quel que soit le service, que vous prenez en charge un patient, vous, en tant que médecin, vous êtes censé avoir un contact correct avec la famille de ce patient, de savoir écouter, les écouter, leur donner du temps, les rassurer, leur donner des informations, bien évidemment, et de cibler les informations que vous allez donner.

Ça, c'est important, parce que dire tout à une famille, n'importe comment, vous savez, alors moi, je vous donne un exemple. Moi, j'avais une jeune interne au service qui travaillait très, très bien et qui adore la réanimation et qui adore faire tout en réanimation, donc poser un cathéter, envoyer un prélèvement. Elle était un peu excitée de faire tout ce qu'il y a à faire au niveau du service.

Et un jour, justement, en parlant du contact avec la famille, elle s'arrête pour discuter avec la famille. Elle commence à discuter avec eux, elle explique un peu l'état du patient et après, elle passe de l'état du patient, elle est en train de raconter ce qui s'est passé au patient. Il est venu, on l'a pris du service, il était grave, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au niveau du service, s'il y avait un arrêt cardiaque, on ne sait pas.

Alors après, on l'a pris, on a fait ceci, on a fait cela. Alors la famille, elle ne retient que l'arrêt

cardiaque, dont on n'est pas sûr et dont l'interne, elle est en train de parler, de raconter, c'est comme si elle racontait à son ami interne ou à un collègue ou à un résident avec qui elle est en garde, alors qu'elle a oublié qu'elle est en train de parler avec la famille qui va prendre en considération toutes les phrases qu'elle a prononcées. Et donc finalement, on se retrouve avec une famille qui cherche à parler avec les seniors, avec les responsables du service, qui sont là pour nous dire, il y a un arrêt cardiaque, c'était comment, c'était quoi, de quoi vous parlez, madame ? Non mais oui, le médecin nous a dit ça et voilà.

On trouve une difficulté finalement à corriger. Et l'interne finalement, c'est juste qu'elle a prononcé des infos, en fait elle a donné des informations dont elle n'est pas sûre et finalement c'est une faute, mais aussi elle a voulu donner le maximum d'informations à la famille, mais après, il faut donner, mais il faut savoir ce qu'on doit donner aussi. Il faut savoir comment le dire aussi.

Il y a des gens parfois qui sortent, des médecins, de jeunes médecins, parfois même des résidents, qui sortent parler avec les familles. Le patient, il est en train de mourir, ils sont en train de dire, écoutez, de toutes les manières, il est grave, je pense qu'il va mourir dans une demi-heure. Et la façon avec laquelle on annonce ce genre de trucs doit être préparée, il y a toute une préparation qui doit se faire à la famille.

Imaginez-vous à la place de cette famille, on n'aimerait pas que quelqu'un de nous soit dans une situation pareille, qu'on vous balance comme ça des informations qui sont un peu choquantes, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a des règles finalement de communication. Ce sont des choses qu'on apprend avec le temps, qu'on apprend parce qu'il faut vraiment vivre ces moments-là pour apprendre.

Et là, c'est juste pour revenir au soin palliatif. Le soin palliatif, la famille, elle sait que le pronostic est mauvais. Donc déjà, dans cette situation, il y a un truc qui est un peu plus facile, si on se permet de le dire, parce qu'ils sont au courant du pronostic.

Ce n'est pas à nous de le dire, ils le savent déjà. Mais par contre, même s'ils savent que leur patient va mourir, par exemple, qu'il est dans un stade terminal, vous savez que la famille, elle tient à ce membre-là. Et donc, par moment, ils savent qu'il va mourir, mais en même temps, pour eux, il est encore vivant.

Donc ils le considèrent comme un vivant. Donc il faut savoir parler, savoir communiquer avec la famille. Bien sûr, il faut toujours leur expliquer.

Mais comme je vous ai dit, il faut savoir quoi expliquer et comment le faire. D'accord ? Pour ne pas tomber dans l'excès. Et bien sûr, pour qu'il y ait toujours ce lien de confiance entre la famille et entre le médecin, ou entre la famille et l'équipe soignante, quelle que soit la situation.

Assurer l'accompagnement et le soutien psychologique de la famille. Alors, vous savez qu'ici, c'est un peu plus... On fait le soutien psychologique aux patients, et on doit le faire aussi à la

famille. Donc vous avez un double travail, si vous voulez.

Mais aussi, il faut préparer la famille au deuil. On se place toujours dans les soins palliatifs, au stade évolutif terminal. D'accord ? Il faut préparer la famille au deuil.

Il faut toujours leur rappeler ce pronostic. Et que voilà, c'est vrai, mais de toutes les manières, il n'est pas en train de souffrir. On est en train de l'accompagner.

Mais toujours revenir au fait que c'est un patient, quand même, qu'il ne faut pas oublier. Il est en phase terminale. Il ne faut pas l'oublier, il faut le dire.

Il faut le dire à chaque fois, mais d'une manière gentille, tout en montrant qu'on est là pour l'accompagner, etc. Et là, c'est une préparation, finalement, de la famille au deuil. Et ça, c'est très, très important.

L'équipe soignante, donc on a parlé du patient, de son entourage qui est sa famille. Alors là, il y a l'équipe soignante, l'équipe qui prend en charge ce patient. Il faut savoir travailler en équipe.

Il faut savoir collaborer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester, nous, comme ça, dans une coquille. On ne communique pas avec les autres.

Et ça, ça fait partie de vos compétences en tant qu'étudiant en médecine. Parmi les compétences que vous devez acquérir, si vous voulez, au cours de votre formation médicale, avant de devenir des médecins, c'est justement cette, si vous voulez, facilité à communiquer, le savoir, savoir communiquer avec vos collègues, avec les autres disciplines, etc. Plus on communique, plus le résultat est meilleur.

Moins on communique, moins le résultat est meilleur. Et parfois même, il y a des catastrophes. Et ça, ce n'est pas juste en soins palliatifs.

Même dans votre travail quotidien en tant que médecin. Je vous donne un exemple. Je suis réanimateur.

Je fais une spécialité qui est transversale. On dit que c'est une spécialité qui est transversale parce qu'on travaille avec tout le monde. Et je n'ai pas envie de parler avec le chirurgien.

Je n'ai pas envie de parler avec le responsable du bloc. Je n'ai pas envie de parler avec je ne sais pas qui, avec le radiologue. C'est n'importe quoi.

Il faut qu'on parle. Il faut qu'on discute avec ces gens-là. Parce que le radiologue, si je prends mon téléphone et que je l'appelle, que je lui dis, tiens, je vais descendre te voir.

J'aimerais bien voir ces clichés, le scanner, parce que je ne comprends pas trop comment vous dites dans le compte-rendu que, voilà, je ne sais pas. J'aimerais bien venir. Alors, le radiologue, il va vous dire, descendez, on va voir ensemble.

Et donc, vous êtes là à discuter. Vous pensez que, donc, devant déjà le cliché ou devant le scanner, vous êtes en train de discuter. Donc, il y a en fait cette communication qui va vous permettre de comprendre mieux.

Alors, lui, il va prendre des informations du médecin clinicien, parce que nous, on est cliniciens, on est en contact avec le malade. Et nous, on va prendre des informations, si vous voulez, du radiologue qui est là, c'est sa spécialité, et donc, il est en train d'interpréter avec nous les images, etc. Donc, on va prendre finalement le patient dans sa globalité, patient, clinique, mais aussi ce qui se passe sur le plan radiologique.

Donc, cette communication, si vous voulez, elle est très, très importante. Ça permet aussi de coordonner nos gestes et notre prise en charge. C'est-à-dire que je sais que le médecin traitant, je dis du n'importe quoi à l'oncologue, il donne des médicaments, si vous voulez, à son patient cancéreux en fin de vie.

Alors, on m'appelle, moi, en tant que réanimateur pour prendre en charge ce patient, pour l'alimenter, etc. Je vais communiquer, je vais lui dire, au médecin traitant, je vais lui dire, voilà, je vais démarrer l'alimentation, tel est le protocole, voilà ce que je vais faire. Alors, lui, il va me dire, oui, je pense qu'il faut attendre un peu, parce que le médicament que je lui donne, peut-être qu'il donne des nausées, des vomissements, peut-être que ce ne sera pas intéressant de faire ceci.

Donc, on va coordonner nos gestes, nos prescriptions, notre façon de travailler. Et ça, c'est très, très important pour avoir un résultat. Qui est quoi, le résultat, finalement? Le résultat, c'est d'accompagner correctement le patient en fin de vie.

C'est ça, notre objectif, finalement. Alors, là, on va commencer par voir les notions dont on a parlé tout à l'heure sur les soins palliatifs. Alors, il est qualifié de palliatif la période d'évolution d'une maladie inguérissable.

S'il vous plaît, reprenez le mot inguérissable. Dans laquelle les traitements n'ont plus pour objectif de prolonger la vie. On n'est pas dans le curatif.

Les efforts thérapeutiques et les investigations en pourbut alors dans cette phase-là, le soulagement des symptômes, dont la douleur, le confort et le bien-être du malade, la qualité de vie prioritaire. Donc, dans cette définition, quels sont les points essentiels que vous pouvez faire sortir de cette définition? Sur la notion ou la définition des soins palliatifs. Inguérissable, c'est-à-dire que nous, on ne traite pas ici.

On n'est pas dans le traitement curatif. La maladie, elle est inguérissable. Très bien, là, c'est un mot qui est intéressant, oui.

Améliorer la qualité de vie. Améliorer la qualité de vie. Il y a une notion qui est importante aussi.

Si vous voyez, on a parlé des efforts. Ce qu'on va faire, nous, en tant qu'efforts thérapeutiques et d'investigation en pourbut, le soulagement des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie de ces patients-là. Retenez, s'il vous plaît, retenez cette définition.

Donc, elle dit, c'est la définition de quoi? Des soins palliatifs. Et qualifier de curative. Curative, c'est la période de l'évolution d'une maladie au cours de laquelle les traitements peuvent entraîner une guérison, une survie de longue durée ou une rémission complète.

Vous voyez un peu la différence. Là, on est dans le curatif. Le curatif, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une évolution d'une maladie qu'on est capable de guérir avec nos traitements, nos approches, etc.

On appelle ça la phase curative. Et qualifier de terminal, la période pendant laquelle le décès est inévitable et proche. C'est le petit patient qui est chez lui à la maison, stade terminal d'un cancer, qui ne veut plus s'alimenter.

Il ne veut plus s'alimenter. Par moments, il est inconscient, il ne s'alimente pas, il n'est pas hydraté. Donc, c'est justement une question de quelques heures ou quelques jours seulement pour la survie.

Et donc là, c'est ce qu'on appelle la phase terminale. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre la phase palliative, la phase curative et la phase terminale? Est-ce que vous avez compris la différence? C'est bon? Oui? Pardon? Longue durée, non. Non, longue durée, non.

Mais ceci dit, ça peut être une survie de 1 an, 2 ans, 6 ans, mais ce n'est pas une longue durée non plus. Tu veux dire longue durée, c'est-à-dire qu'il peut vivre pendant 10 ans ou non. Là, on est dans une autre phase.

On est dans la phase curative. Donc, qu'est une ML en fait? Je l'acquète le patient pendant 10 ans. Il faut absolument qu'on lui fasse quelque chose.

Parce que sinon, la maladie va continuer à évoluer. Et donc, c'est incompatible avec justement une survie. Vous laissez évoluer un cancer pendant des années, la maladie va mourir, ce serait certain, sans qu'on lui donne des investigations et des traitements adaptés.

D'accord? Alors, si on veut voir ici sur ce schéma, la période curative, c'est depuis qu'on a fait le diagnostic, si vous voulez, d'un cancer. D'accord? Le patient, il vient de savoir qu'il a un cancer. Et donc, on a commencé à traiter.

Peut-être qu'il y a de la chirurgie, de la chimio associée à la chirurgie, ou quel que soit le traitement adjuvant, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, je ne sais pas, en fonction du type de cancer. Après, commence la période palliative. Dans la période palliative, il y a la période palliative, si vous voulez, initial, hier, c'est la période qu'on appelle, nous, soin palliatif.

Et il y a la période palliative terminale. Terminale, quand il y a le mot terminale, on est vraiment dans l'agonie. Donc, on est dans la phase finale, si vous voulez.

Alors, dans cette phase de palliative, on peut trouver un patient cancéreux, chez qui on donne, par exemple, on fait des séances, par exemple, de chimiothérapie, mais pas dans un but de guérir la tumeur, mais plutôt d'améliorer, si vous voulez, sa qualité de vie au cours de cette phase. Mais on est sûr que ce patient ne va pas guérir, et d'ailleurs, il y a déjà les métastases qui se sont installés. Donc, avant même de parler de cette phase.

D'accord ? La phase, c'est ce qu'on appelle les soins oncologiques de support. Parfois, on peut donner de la chimio chez des patients, pas dans un but curatif, mais d'accompagnement, lorsque le patient, l'état de santé du patient le permet. D'accord ? Parce que même pour la chimio, les protocoles de chimio, ça dépend aussi des produits qu'on utilise, mais généralement, il faut avoir quand même un patient qui va tolérer, si vous voulez, ce genre de soins.

Mais ça reste des soins dans un but palliatif, et non pas dans un but curatif, parce que si c'est dans le but curatif, on est plutôt dans cette phase-là. D'accord ? Et puis, bien sûr, c'est l'agonie, c'est la phase palliative terminale. Généralement, c'est un patient qui va mourir dans quelques jours ou dans quelques heures.

Oui ? Palliative. C'est-à-dire ? Un exemple de l'événement, par exemple, un sujet en fin de vie, l'état à la raison d'un trauma crânien. Si c'est ce que vous voulez.

Est-ce qu'on va l'opérer ? On ne va pas l'opérer à cette phase. Non. Un encombrement, là, un encombrement, c'est juste des sécrétions.

Vous parlez de terminale ou vous parlez de palliatif ? Palliatif. Des encombrements, on reçoit des patients pour des aspirations. Ce n'est pas des gestes qui sont agressifs.

D'accord ? On peut faire ça. Mais après, quand il est dans le terminal, même s'il est encombré, on ne fait rien dans la phase terminale. Quand vous êtes dans cette phase, toute cette phase, généralement, s'il y a un incident ou un truc qui arrive à ce patient, en dehors de sa pathologie, trauma crânien, fracture de fémur, on ne fait rien.

On ne fait absolument rien. D'accord ? Est-ce que vous avez compris un peu la différence entre les différentes phases ? C'est bon ? Alors, comment situer notre patient ? Je vous ai vu sur la plaque précédente, en oncologie. Finalement, il faut situer le patient.

Où est-ce qu'il est de ces différentes phases avant de commencer la procédure, bien évidemment ? Et aussi, il y a un certain nombre de scores qui nous permettent généralement, en gériatrie, en oncologie, ce sont des scores qui sont un peu différents en fonction du patient, qui nous permettent, si vous voulez, d'avoir une idée sur l'état de ces patients au moment où on va démarrer la procédure. Comme, par exemple, cet indice utilisé chez les patients des sujets âgés.

Vous voyez qu'il y a des scores, en fait, et qu'il faut calculer en fonction de l'activité du patient, etc.

Par exemple, je dirais état grave, il nécessite un soutien actif, absence totale d'autonomie, on va dire que le score est à 20%, par exemple. Un patient qui est moribonde, processus fatal, on va dire que le score est à 10%. Généralement, ce score, il permet de situer le patient par rapport à ses activités, par rapport à son état général, parce que quand on parle, par exemple, ici sur ce score-là, s'il est à 10%, franchement, est-ce que c'est un patient... Vous allez faire quelque chose chez ce patient.

Non, il est déjà moribonde, donc il ne fait pas partie de la palliative initiale, il est plutôt dans la palliative terminale, donc on ne va pas aller plus loin que ça. Mais après, s'il est, par exemple, un patient qui peut mener une activité normale, avec des symptômes qui ne sont pas très importants, etc., et qui est autonome, donc là, ça vous aide, finalement, dans la mesure où vous allez dire, ce patient-là, si on entame avec lui la procédure, ça va tenir, ça va donner des résultats, donc ça va être une bonne qualité de vie, finalement, c'est notre objectif. Les scores, ce n'est pas des scores à apprendre, c'est juste un site informatif, même moi, je ne les connais pas par cœur, je cherche à chaque fois que j'ai envie d'avoir une idée sur le scoring, mais sinon, c'est des scores, et on a plein, l'OMS aussi avait fait des scores, etc.

Alors, quelques concepts, pour parler, avant de parler de l'alimentation, et avant de voir ce qu'on fait pour l'alimentation, etc. Dans notre société, l'alimentation est une source de vie et de plaisir, et donc, cette notion est très importante, parce que vous voulez alimenter un patient pour améliorer sa qualité de vie, il faut que vous soyez dans ce concept-là, c'est-à-dire, il faut que ce soit un moment de plaisir, mais chez Redjibou, le patient, vous allez le mettre à table, et voilà, tu manges ça, il faut manger ça, etc., il ne va pas le manger, et il n'est pas dans la source de plaisir, ni rien du tout, il serait dégoûté de ce que vous lui présentez, il ne va pas manger, donc ça ne sera pas efficace. Si l'alimentation a un rôle nutritionnel, qui peut parfois imposer certaines contraintes, il a également celui de répondre aux habitudes et aux goûts de la personne, et d'ailleurs, raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut faire une évaluation, l'évaluation n'est pas que clinique, elle n'est pas que biologique, mais elle se base aussi sur l'anamnèse, il faut connaître ce patient, comment il vit, qu'est-ce qu'il aime manger, quelles sont ses préférences, pourquoi ? Parce que vous allez vous baser dans votre procédure, sur ces données-là.

Quelqu'un qui aime, je dis du n'importe quoi, qui aime, je ne sais pas, des fruits particulièrement, certainement vous allez le lui donner, parce que vous savez qu'il l'aime bien, donc il va l'accepter facilement, il va le manger, il va avoir du plaisir à le manger, et donc c'est ça ce qu'on veut finalement, c'est ça ce qu'on veut, on veut qu'il soit tranquille, qu'il mange ce qu'il veut, qu'il soit bien, etc. Et donc, cette notion, elle est très importante, il faut prendre en considération les habitudes et les goûts de la personne. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, l'alimentation n'est pas obligatoire à instaurer, tout dépend du stade évolutif de la maladie et de l'accord, bien sûr, de la personne qui est concernée.

Donc, la nutrition et l'hydratation, ils sont déterminés en fonction du contexte bien sûr du patient, il est palliatif, il est curatif, il est terminal, il est quoi, les objectifs, nos objectifs, ils dépendent du pronostic du patient bien sûr, lorsqu'on est dans le pronostic du patient, si on peut l'améliorer, ça veut dire qu'on est plutôt dans le curatif, l'amélioration du pronostic, là, on ne va pas en parler, mais lorsqu'on est dans la deuxième situation, c'est la situation palliative avec une maladie incurable, mais avec une certaine espérance de vie, c'est-à-dire qu'il va vivre quelques semaines, quelques mois, quelques années aussi, deux ans, un an, c'est possible. Donc, il y a une petite espérance de vie, mais pour une maladie d'évolution fatale dont le pronostic est déjà connu, il est indiscutable, on n'est pas dans la guérison, il est inguérissable. D'accord ? Alors là, l'alimentation et l'hydratation, ils ont comme objectif d'obtenir une meilleure qualité de vie, bien sûr, en lien avec un projet global et un intérêt global, si vous voulez, de la prise en charge.

La phase terminale, comme on a dit, ça ne sert à rien, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Donc finalement, quand vous voyez ça, vous voyez que finalement, l'objectif de notre prise en charge, elle dépendra du stade évolutif du patient et notre objectif, il sera différent chez les trois types de patients. On ne va pas penser de la même manière, on ne va pas instaurer les mêmes protocoles.

La règle, c'est quoi ? Quel que soit le contexte et les objectifs, la décision nécessite l'information du patient, son accord si possible, bien sûr, si le patient parle, et l'avis de la famille, rappelez-vous de ce point-là. Alors, on parle depuis tout à l'heure de la démarche globale. C'est quoi cette démarche globale ? La prise en charge nutritionnelle, elle est définie comme un soin de support.

Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale, d'une prise en charge globale. Il faut qu'il y ait des... Il faut peser le bénéfice- risque. Qu'est-ce qu'on va rajouter à ce patient ? Qu'est-ce qu'on va lui offrir ? Et comment faire pour offrir à ce patient le maximum de ce qu'on peut faire, sans pour autant tomber dans les complications et aggraver l'état ? Et je vous rappelle l'exemple de l'hydratation et de la surcharge, etc.

Tu as une question ? Alors, généralement, on le suit, mais après, s'il est diabétique, bien évidemment, si vous donnez du sucre ou des aliments qui sont sucrés de manière déraisonnée, certainement, vous allez aggraver son état, parce que, s'il refuse, vous devez respecter son volupté. Je l'ai dit tout à l'heure. Un patient, le patient, dans cette phase, je reviens toujours et je dis dans la phase palliative, il a le droit de vous dire non et vous êtes obligés d'accepter.

D'accord ? Il va mourir, accélérer sa mort, on ne sait pas. Mais oui, alors s'il vous dit non, de toutes les manières, s'il dit non, vous pensez que vous allez, comment vous allez faire pour forcer ce protocole que vous voulez faire ? Comment vous allez faire ? Un patient, dans un sujet âgé, déjà, vous allez commencer à parler, déjà, nous, nos grands-parents, en fin de vie, vous mangez ça ? Non, je ne mange pas. Il ne va pas manger.

D'accord ? Blème les grands-parents. Les parents, quand ils dépassent l'âge de 60 ans, ça devient un peu ça. Je ne veux pas ça, je veux ça.

Et donc, de toutes les manières, vous ne saurez pas faire. Et puis vous lui imposez, il va peut-être cracher, il va peut-être vomir, ce n'est pas intéressant. Donc normalement, on n'impose pas.

En soins palliatifs, on n'impose pas. Mais après, il y a toujours des moyens, peut-être essayer de parler avec lui, la famille qui peut, parfois, la famille peut jouer un rôle positif dans cette démarche. Alors, là, j'ai mis cette plaque juste pour vous donner une idée sur la dénutrition, parce que quand on parle de soins palliatifs et d'alimentation, ce sont des patients qu'on va évaluer et évaluer l'état nutritionnel avant de démarrer le protocole.

L'évaluation de l'état nutritionnel est toujours intéressante et la nutrition, finalement, est un pilier, si vous voulez, intéressant de la vie, de la santé, la nutrition. Et parfois, on ne sait pas, en fait, l'importance de la nutrition, justement, et l'importance d'avoir un état nutritionnel correct chez les patients d'une manière générale. On a l'impression que, oui, il est un peu maigre, mais on s'en fout.

Non, mais celui qui est maigre et qui va se faire opérer, la réponse ou, si vous voulez, le résultat chirurgical ne va pas être bon. Il peut même faire des complications parce que, justement, il est dénutri, etc. Et, justement, c'est pour ça qu'au cours de l'évaluation pré-anesthésique avant le geste chirurgical, on évalue l'état nutritionnel chez les patients qui vont subir une chirurgie lourde.

Pourquoi ? Pour les préparer. Parfois, on les prépare même avant le geste chirurgical, avant d'arriver au jour J où on va opérer le patient pour avoir un bon résultat par la suite et pour éviter les complications parce qu'un patient dénutri, c'est un patient qui va s'infecter. C'est un patient qui va vous faire le sepsis.

C'est un patient qui va lâcher ses sutures. C'est un patient qui va faire des complications respiratoires post-opératoires et qui peut mourir, pas par sa pathologie, mais plutôt par des complications. Donc, vous voyez, il y a une grande importance.

Cette plaque, c'est juste à titre informatif. C'est pour vous voir le retentissement, finalement, de la dénutrition. Regardez ce qui est en rouge.

Ce sont les patients qui sont dénutris et, en jaune, les patients qui ne sont pas dénutris. Regardez. Donc, il y a une augmentation du taux de mortalité.

Vous voyez, d'une manière très significative de la morbidité aussi, tout ce qui est complications, le survenu des infections et les hospitalisations avec la durée d'hospitalisation qui sera plus longue chez les patients qui sont dénutris. Donc, vous voyez que, finalement, l'intérêt, finalement, de chercher la dénutrition chez tout ce type de patients. Alors, dans notre contexte, dans notre contexte, là aussi, il y a une autre notion.

C'est que la dénutrition, elle tue lorsque vous avez plus de 50% des réserves protéiques qui sont déjà épuisées. Alors, avant de démarrer, on va commencer par la nutrition. Par la suite, on va passer à l'hydratation.

Alors, avant d'alimenter un patient, vous imaginez devant un patient en soins palliatifs ou un sujet âgé, par exemple, au cancéreux, en soins palliatifs, et vous voulez démarrer l'alimentation. Avant de démarrer l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous ? Un patient, il y a un coul, généralement, habituellement et normalement, il va manger par voie orale, et vous allez lui donner à manger. Est-ce qu'il a des vomissements ? Est-ce qu'il a des nausées ? Est-ce qu'il a des lésions au niveau de sa bouche ? Est-ce qu'il a des ulcères ? Est-ce qu'il a des aftes ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va empêcher ? Oui, il veut manger, mais il ne peut pas manger.

Et vous, vous allez croire que le patient, il est en train de glisser, de partir vers la fatalité, mais le patient, déjà, il veut manger, mais sauf que il y a des choses à chercher. Et donc, c'est important. Il faut rechercher et traiter les symptômes gênants.

Ça s'appelle les symptômes gênants. Il faut voir si le patient est douloureux, s'il est dyspnéique, s'il a des nausées, vous venez de le dire, des vomissements, la constipation, la muqueuse buccale ou digestive, la dépression. Imaginez-vous devant un patient qui est dyspnéique, un vieux qui a une cardiopathie, un cancer, tout ce que vous voulez.

Est-ce qu'il va manger ? Il ne va pas manger. Un patient qui a mal, cancéreux, ils ont des métastases, ils ont mal. Est-ce que vous, quand vous avez mal, vous mangez ? Hein ? Parfois, on mange, malgré la douleur.

Mais, généralement, chez un cancéreux, fin de vie, la douleur, elle est tellement importante. La souffrance, elle a duré du temps, quand même. Donc, finalement, c'est un patient qui ne va pas manger.

Comme vous l'avez dit, nos vomissements, c'est gênant, il ne va pas manger. Un patient CARD, il ne va pas manger, c'est sûr. Il a eu une constipation.

Vous savez que la constipation, si vous êtes constipé, vous n'allez pas manger. Chez l'enfant, c'est très connu. Les enfants, généralement, quand des enfants qui sont habituellement, en fait, ils ont l'habitude de manger normalement, etc.

Le jour où l'enfant ne veut pas manger, la première chose à laquelle la maman, elle pense, c'est est-ce qu'il est constipé depuis quand il a fait ses derniers sels, etc. On est constipé, donc on est plein, on n'a pas envie de manger, c'est normal. La mycose buccale, bien sûr, il a mal, il y a de l'infection.

La dépression, quand on est déprimé, il n'est pas pris en charge de la multidisciplinarité, on veut manger. Quand on est déprimé, il ne va pas manger non plus. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il faut

insister avant de commencer de parler de l'alimentation sur les soins de la bouche.

Les patients, il faut examiner, évaluer, voir ce qu'il y a, prêter et avoir ses soins de bouche d'une manière si vous voulez fréquente. Là, j'ai mis une phrase, comment avoir ses plaisirs quand on a la bouche qui est sèche, une mycose, des ulcérations et des douleurs au niveau de la bouche, on ne va pas manger. Les soins, ils sont importants.

Alors, comment on va traiter ça? Tout simplement, il faut le faire d'une manière très régulière, donner des antifongiques lorsque vous avez des mycoses, donner des antalgiques lorsque le patient a mal, lorsqu'il y a des douleurs. Il faut savoir que le sujet en soins palliatifs, que ce soit un sujet âgé ou un sujet cancéreux, généralement, ils ne parlent pas trop de leurs douleurs. Ils ont tellement vécu dans la douleur, ils se sont un peu habitués de la douleur, ils ont mal, mais ils ne le disent pas, ils n'expriment pas.

Donc, il faut essayer de parler avec ces patients et de leur demander de s'exprimer et de les faire sortir un peu de cet état pour qu'ils vous disent qu'ils ont mal. Le sujet âgé, quand vous voyez vos grands-parents, ils ne disent pas qu'ils ont mal. Certains jours, vraiment, c'est la catastrophe, c'est là où on découvre qu'ils avaient mal depuis un mois, alors qu'ils sont calmes, ils ne disent rien du tout.

Donc là, il faut savoir les faire sortir, bien sûr. La bonne hygiène, ça c'est normal. Il faut toujours avoir une bonne hygiène de bouche, veiller sur ça et expliquer ça à la famille, à l'entourage.

Une autre notion qui est très importante, les sujets âgés, généralement, généralement, ils sont multitâts, il est cardiaque, il est hyper tendu, il a la goutte, il est diabétique, il a le rhumatisme, il a je ne sais pas quoi. Donc, ils sont polymédiqués. Ce sont des patients, ils sont en train de prendre un si caché, cette cachée, à chaque fois qu'ils veulent s'alimenter avant de manger, ils sont en train de prendre un si comprimé, cette comprimé de la tension, de la goutte, de je ne sais pas quoi.

Vous voyez que, imaginez-vous en train de prendre tous ces comprimés au moment du repas. C'est dégoûtant. La personne, à la limite, n'aura plus envie de manger.

Regardez cette quantité de comprimé qu'elle avale. Donc nous, en tant que professionnels de santé, au cours de ces démarches-là, on doit appeler les médecins traitants et discuter de l'intérêt de garder ces médicaments. J'appelle son cardiologue, est-ce que c'est de l'hypertension, vous pensez que votre patient a vraiment besoin de garder l'antihypertenseur ou pour vous, vous pensez que c'est pas la peine ou le traitement de la goutte, est-ce que c'est obligatoire de l'avoir ? Est-ce que le régime seul ne serait pas efficace chez lui en fin de vie, etc.

Donc vous allez discuter quand même de garder ou ne pas garder ces médicaments. C'est très très important. Moins de médicaments vous avez, plus le patient va s'alimenter et va trouver du plaisir à s'alimenter.

Est-ce que vous avez compris cette idée ? Voilà. L'évaluation du patient. Bien sûr, l'évaluation, c'est l'anamnèse, c'est ce qu'on doit faire initialement, voir ses antécédents, les médications, les médicaments en cours, voir un peu les effets secondaires des médicaments, parce que parfois les médicaments donnent des nausées, des vomissements, donc ils peuvent finalement empêcher le protocole qu'on va entamer.

Bien sûr, il faut peser le patient, avoir une idée. On va l'alimenter, donc on doit avoir une idée sur son poids initial avant de démarrer. L'état de bouche, chercher tout ce qui se passe au niveau de sa bouche, voir s'il a un dentier ou pas.

Il a un dentier, Ramari et Hercules sont dentiers, donc il faut absolument qu'il l'aille pour manger. Voir s'il a des problèmes de déglutition. Vous savez, il y a des patients qui sont en fin de vie, qui ont des cancers de la sphère ORL, larynx, pharynx, je ne sais pas quoi, et donc parfois ils ont des tumeurs qui sont là, puisqu'ils sont dans le palliatif, ils sont gênants, ils ont des problèmes de déglutition, donc certainement, ces patients-là, ils peuvent ne pas déglutir, ils peuvent ne pas s'alimenter correctement, et donc il faut détecter cette anomalie, un problème de déglutition, il faut savoir le détecter.

D'ailleurs, vous allez observer votre patient, vous allez lui donner à manger, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous avez tout le dossier médical, donc vous savez s'il a une tumeur, par exemple, vous avez déjà une idée sur ce qui se passe. Rechercher les nausées, les vomissements, l'altération de goût, chez quelques patients, il ne goûte pas, le goût est perturbé.

Voir s'il a, le patient, il a des intolérances, s'il a une intolérance au gluten, par exemple, je donne un exemple seulement, alors il ne faut pas le lui donner, bien évidemment, ça ne sert à rien. Voir s'il a, le patient, il a un ballonnement, il a des gaz, il a des trucs, donc il faut corriger ces symptômes avant de démarrer, bien sûr, l'alimentation, pour qu'il y ait un résultat à ce que vous faites. Les goûts, les préférences, la corrélation entre les différents symptômes qu'on observe chez ce genre de patient, vous savez, quand on a mal, on a des nausées.

Lorsqu'on a des nausées, on est anorexique, on n'a pas envie de manger. On est anorexique, on va avoir une perte de poids. Lorsqu'il y aura cette perte de poids, il y aura la cachexie.

Donc vous voyez, finalement, ce sont des symptômes, c'est comme un cercle, finalement, et le résultat, finalement, c'est la dénutrition et c'est l'aggravation, bien sûr, de ces patients-là. Pareil ici, en parlant de la dépression, le patient ne va pas manger. Lorsqu'il ne va pas manger, il va avoir une perte de poids.

Lorsqu'il va avoir la perte de poids, il sera fatigué. Quand il sera fatigué, il sera moins coopérant. Lorsqu'il sera moins coopérant, il ne va pas manger.

Et donc voilà, c'est le cercle dont on a parlé tout à l'heure. Alors, cette cachexie ou cette anorexie cachexie, elle est souvent présente chez le sujet âgé, mais surtout chez les patients cancéreux.

Déjà, il faut savoir que l'anorexie, elle est présente chez à peu près 50% des nouveaux patients cancéreux détectés, comment dirais-je, des nouveaux patients qui viennent d'être détectés avoir une pathologie cancéreuse, par exemple.

Déjà, ils ont cette anorexie. Vous imaginez, avec l'évolution de la maladie, avec les traitements, avec tout le truc que le patient a subi lors de l'évolution de sa maladie, vous allez imaginer qu'il y aura plus un pourcentage qui est beaucoup plus important chez les patients qui sont à la phase cognitive. Et donc l'anorexie, elle est très, très fréquente, bien sûr, chez ces patients-là.

L'origine, elle est soit due à l'évolution de la maladie, le cancer, les effets indésirables des opiacés, vous savez, ce sont des patients qui ont les douleurs de métastase, etc., qui sont sous-opiacés, sous morphiniques par des patches, les comprimés, etc. On en a parlé la dernière fois sur le cours de la douleur. Et la prise de ces médicaments-là donne des effets secondaires.

Parmi ces effets secondaires, il y a justement l'anorexie. Il y a aussi cette perte de goût au cours de l'évolution de la maladie cancéreuse et l'altération de l'odorat. Lorsque vous avez ces anomalies-là, ça ne permet pas... En fait, ça donne aux patients cette anorexie et donc finalement une mauvaise acceptabilité, si vous voulez, de l'alimentation, de tout ce qui est nourriture.

Alors, pour améliorer ces patients-là, en ce qui concerne leur alimentation, on privilégie généralement la voie orale, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres voies d'alimentation qu'on peut utiliser. Ces patients ont soins palliatifs, mais ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut aller vers la voie orale en premier, parce que c'est la voie normale. Tout ce qui est normal ou tout ce qui est proche de la normale est beaucoup plus bénéfique de ce qui est artificiel.

Un patient qui respire normalement est un patient qui est plutôt proche de la vie que de la mort. Un patient qui est artificiellement ventilé, donc c'est l'intubation, c'est la ventilation mécanique, on imagine toutes les complications, toutes les complications qui peuvent survenir, et donc il est plutôt plus grave. Donc plus on est proche de la normale, plus on est bien dans nos procédures.

Donc, privilégier cette voie normale, il faut privilégier aussi une atmosphère qui est relaxante. Enfin, de vivre en train de manger, où je ne sais pas quoi, etc., c'est pas l'atmosphère idéale si vous voulez. Il faut que la position soit adéquate aussi.

Pour manger, il faut s'asseoir, c'est ce qu'on a appris quand on était petit. Et c'est ça finalement, il faut vraiment s'asseoir, donc il faut essayer d'asseoir le patient, et d'essayer d'asseoir, parce que je ne sais pas, parfois il y a des états neurologiques, le patient il est un peu dans des positions qui ne sont pas bonnes, mais après il faut s'approcher de la position assise, parce que finalement c'est la position adéquate. Il faut que le patient soit confortable.

S'il est assis sur une chaise qui n'est pas confortable, lui il veut manger, mais après il n'est vraiment pas du tout confortable, donc il est gêné. Donc là, il faut faire attention à ce genre de

trucs. Les aliments qui sont préférés, bien sûr, et qui vont stimuler l'appétit du patient, on en a parlé tout à l'heure, il faut privilégier les repas fractionnés.

Au lieu de lui donner, par exemple, trois repas, avec de grandes quantités, allez, allez, vous mangez un maillard d'atagine, il faut que le patient mange fractionnés les repas. Vous pouvez faire le premier repas à 8h du matin, par exemple, le deuxième, une petite collation vers 10h, vers 11h. Un autre point aussi qui est important, le patient, à 8h tu manges, à 12h, le déjeuner.

Ça peut être 12h30, ça peut être 13h. Il faut être flexible, garder cette flexibilité, parce que tout ce qui est comme ça dérange en principe. Et donc plus on est flexible, plus la personne est à l'aise.

C'est aussi une notion qui est très importante. Je l'ai mentionné ici, c'est l'horaire souple. Il faut privilégier aussi les boissons nutritives faits maison, parce qu'elles sont riches en vitamines, etc.

Et elles sont mieux tolérées, si vous voulez, que tout ce qui est vendu à l'extérieur. Il ne faut pas oublier de donner les suppléments nutritifs vitaminiques en cas de besoin, lorsqu'on sent que l'alimentation, finalement, n'est pas très, très adéquate. Alors, les causes de la dénutrition.

La dénutrition, elle peut être soit d'origine exogène ou d'origine endogène chez ces patients-là. D'origine exogène, ça veut dire qu'il y a un problème dans les apports. Et endogène, c'est un problème lié à un problème interne de maladie de milieu intérieur.

Donc, la dénutrition exogène, c'est soit lié à l'anorexie, dont on vient de parler maintenant, c'est-à-dire que le patient a une anorexie, et donc, cette anorexie, elle va être soit globale, donc il ne mange rien, il n'a pas envie de manger carrément, ou bien une anorexie qui est spécifique à un type d'aliment, par exemple. Il y a aussi cette notion de la satiété précoce. Ce sont les gens qui se sentent pleins.

Si vous voulez, moi, je me sens plein. Précocement, il suffit qu'ils mangent un petit truc, c'est bon, j'en peux plus. Là, bien sûr, s'il va arrêter, c'est qu'il ne va pas s'alimenter, et là, c'est une cause exogène, bien sûr.

Aussi, les obstacles à la nutrition orale, ce sont des causes, si vous voulez, exogènes, parce que si le patient a des troubles de déglutition, il ne va pas s'alimenter, donc on ne va pas faire rentrer de l'alimentation, finalement. Autre facteur qui limite l'alimentation et l'hydratation, ce sont l'ensemble des symptômes qu'on a vus tout à l'heure. C'est des causes, si vous voulez, exogènes, c'est des symptômes qu'on doit éventuellement traiter.

La dénutrition endogène, c'est lorsqu'il y a des perturbations métaboliques internes secondaires à la production anormale des médiateurs qui sont produits par l'hôte ou par la cellule tumorale. Vous savez, les cellules tumorales produisent un certain nombre de molécules, les cytokines, des hormones, des substances qui donnent une certaine, si vous voulez, un état d'hypercatabolisme. C'est une perte d'énergie intérieure liée à l'évolution de la maladie.

Ceci est lié justement chez les cancéreux à la cellule tumorale avec ce qu'elle sécrète, cette cellule tumorale. Ce sont des effets internes liés à des événements intérieurs en rapport avec la maladie cancéreuse, comme exemple, chez les patients qui sont cancéreux. Les conséquences de la dénutrition, on l'a vu tout à l'heure sur la diapositive, c'est la morbidité, c'est la surinfection, c'est l'augmentation de nombre de jours d'hospitalisation, etc.

Finalement, c'est la diminution de l'espérance de vie. Quelqu'un qui ne s'alimente pas, c'est quelqu'un qui va mourir. D'ailleurs, nous, dans notre culture, on dit à quelqu'un qui ne mange pas « Qu'est-ce qui se passe ? » On a cette réflexion de la vie.

Et aussi, chez nos patients, ce qui est marrant chez eux, c'est que le patient se fait opérer pour un cancer du côlon, par exemple, j'ai envie de manger, mais il veut manger. C'est la première chose que le patient réclame. Pourquoi ? Parce que finalement, ça rentre dans notre culture.

Ça veut dire qu'il est en bonne santé. Le mec-là, c'est un signe de bonne santé. Je vous donne à titre anecdotique un autre exemple.

Chez nous, en réanimation, notre chef de service qui vient de quitter le CHU, quand on était encore des résidents, lorsqu'il venait pour faire des visites, s'il trouvait des patients en train de manger, il tournait vers le médecin de garde pour lui dire « Est-ce qu'il y a des patients, mademoiselle ? » Pour moi, un patient qui est cool, et ça, c'était surtout marrant dans le service de réanimation mère, où il rentrait parfois et il trouvait des femmes en train de discuter entre elles. Une en décubitus latéral gauche, l'autre en décubitus latéral droit, depuis leur lit. Ah oui, en train de manger les soupes, etc.

C'était la catastrophe. Si jamais il tombe sur cette situation, le médecin de garde est dans une sale situation. Finalement, c'est un signe de vie.

Bien sûr, la dénutrition va donner une amyotrophie. Les muscles vont devenir de petite taille et ceci est lié à l'alimentation prolongée. Il y a le risque de survenue des escars.

Vous connaissez les escars ? Bien sûr, un patient, il m'indouche les muscles et il va faire des escars. Et bien sûr, la dépression de l'immunité. Un malade dénutrit, c'est un malade qui va se surinfecter.

C'est une immunodépression ou un état d'immunodépression. La déshydratation serait responsable des états de confusion parce qu'un patient déshydraté va avoir des signes de déshydratation. Parmi les signes de déshydratation majeurs, c'est ces troubles de conscience ou la confusion, l'agitation.

Ça fait partie de ces signes-là. Et bien sûr, le risque important sur le ras puisqu'il y a une diminution de la perfusion rénale. On accélère la survenue de l'insuffisance rénale chez ces patients-là qui ont déjà de l'insuffisance rénale installée soit par les traitements adjuvants dans le

cadre de la néoplasie ou bien chez le sujet âgé.

Vous savez qu'avec l'âge, généralement la taille du rein diminue et la fonction rénale devient perturbée. Si vous vous amusez à faire des bilans à vos grands-parents, ils sont bien portants, ils urinent bien, ils n'ont aucun problème, mais ils ont une altération de la fonction rénale qui est manifeste. Comment on évalue cet état nutritionnel de notre patient? Déjà, c'est l'interrogatoire, bien sûr.

Il faut voir bien sûr le diagnostic de cette dénutrition. Depuis quand on doit demander à la famille ou aux patients s'ils arrivent à nous répondre combien il a perdu de kilos, sur combien de temps, pour avoir une idée sur cette altération de l'état général. Rechercher bien sûr les symptômes dont on a parlé tout à l'heure.

Et voir bien évidemment la répercussion de la perte de poids. On va voir si ce patient a perdu l'autonomie parce qu'il est tellement maigrichon qu'il n'arrive pas à faire normalement les tâches qu'il faisait. Généralement, le patient vous dit qu'il a perdu de l'autonomie, qu'il n'arrive plus à se lever pour aller aux toilettes, qu'il se sent fatigué, qu'il n'a pas la force pour se lever.

Parfois, il vous dit qu'il n'a pas la force pour prendre la cuillère pour manger. Je me sens tellement fatigué, etc. Là, ce sont des signes de dénutrition majeure.

Donc, si vous voulez l'alimenter, il faut vraiment l'aider avec la méthode la plus adéquate. On va voir les différentes façons de faire. Comment on fait? L'examen clinique, il y a ce que l'on appelle les mesures anthropométriques.

C'est la mesure du poids, de la taille et de l'indice de masse corporelle qu'on peut calculer par la poids sur la taille au carré. On parle de dénutrition lorsqu'on est inférieur à 21 kilos par mètre carré chez l'homme et inférieur à 20 chez la femme. C'est là où on commence à parler de la dénutrition.

Bien sûr, il y a aussi la mesure des circonférences. Vous savez, on utilise des rubans mètres et c'est avec ça qu'on va mesurer les circonférences. Il faut les mentionner et donner des valeurs de référence avec lesquelles on a commencé et par la suite, au fur et à mesure, qu'on veut évaluer.

Alors, on va refaire ces mesures-là de la même manière et on doit les mesurer de la même façon. Bien sûr, on cherche les signes cliniques de la dénutrition que vous connaissez, la maigreur, la myotrophie et rechercher les signes de déshydratation que vous connaissez déjà.